



BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Nomor : 2489/VII-05/0724
Lampiran : Satu berkas
Hal : Kebijakan Penjaminan ESWL

Malang, 23 Juli 2024

Yth. Direktur / Kepala FKRTL Penyelenggara Layanan ESWL (Daftar terlampir)
di
Malang Raya

Kami manajemen BPJS Kesehatan Cabang Utama Malang menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang baik dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pasal 46 ayat (4) bahwa Manfaat Jaminan Kesehatan yang menjadi hak dari Peserta salah satunya adalah manfaat medis yang terstandar yang efektif dan efisien serta untuk memastikan penjaminan manfaat pelayanan tindakan *Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy* (ESWL) yang efektif dan efisien, perlu disampaikan ketentuan Penjaminan Manfaat pelayanan tindakan ESWL meliputi:

1. Berdasarkan PNPB Batu Saluran Kemih tidak seluruh batu saluran kemih harus dilakukan pengangkatan secara aktif, beberapa kondisi dapat didahului dengan observasi dan atau terapi farmakologis.
2. Observasi dan/atau terapi farmakologis pada batu saluran kemih dilakukan pada kondisi:
 - a. Pada batu ginjal kaliks inferior asimtomatik ≤ 10 mm, dilakukan observasi tahunan. Bila ada penambahan ukuran batu, interval observasi perlu diperpendek.
 - b. Pada batu ginjal dengan jenis batu asam urat dapat diberikan tata laksana farmakologis.
 - c. Pada batu ureter dengan ukuran < 5 mm, jika asimtomatik dan tidak ada indikasi pengangkatan batu, maka dapat dilakukan observasi dengan evaluasi berkala. Batu ureter dengan ukuran > 5 mm dan ≤ 10 mm direkomendasikan untuk dilakukan terapi farmakologis/MET MET (medical expulsion therapy).
3. Indikasi adanya pengangkatan batu ginjal secara aktif antara lain:
 - a. Pertambahan ukuran batu.
 - b. Pasien risiko tinggi terjadinya pembentukan batu.
 - c. Obstruksi yang disebabkan oleh batu.
 - d. Infeksi saluran kemih (Konfirmasi dengan pemeriksaan kultur urin).
 - e. Batu yang menimbulkan gejala seperti nyeri, kolik, dan dapat disertai dengan disuria, hematuria, frekuensi, retensi urin, nyeri suprapubik dan anuria.
 - f. Ukuran batu > 15 mm.
 - g. Ukuran batu < 15 mm jika observasi bukan merupakan pilihan terapi.
 - h. Komorbiditas
4. Indikasi pengangkatan batu ureter secara aktif antara lain:
 - a. Batu dengan kemungkinan rendah untuk keluar secara spontan.
 - b. Nyeri persisten setelah terapi analgesik adekuat.
 - c. Obstruksi persisten.
 - d. Insufisiensi ginjal (gagal ginjal, obstruksi bilateral, atau ginjal soliter).
 - e. Kelainan anatomi ureter.
 - f. Batu tidak keluar setelah 4 - 6 minggu MET

Kantor Cabang Utama Malang

Jl. Raden Tumenggung Suryo 44 Malang
Telp. +62 341 493026
Fax. +62 341 493802
www.bpjs-kesehatan.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

5. Terdapat beberapa pilihan terapi pengangkatan batu saluran kemih antara lain adalah:
 - a. ESWL
 - b. PCNL (*Percutaneous Nephrolithotomy*)
 - c. URS (*Ureterorenoskopi*)
 - d. Operasi pengangkatan terbuka serta laparaskopik.
6. Dalam hal peserta terindikasi untuk tindakan ESWL, agar dipastikan faktor pendukung dan kondisi sebagai berikut:
 - a. Batu ginjal ukuran 10-20 mm.
 - b. Batu ureter ukuran maksimal 20 mm dan dilakukan dengan guiding c-arm dan USG.
 - c. Dapat dimungkinkan dilakukan pada batu ginjal ukuran > 20 mm yang mempunyai kontraindikasi dilakukan tindakan endourologi, dengan didahului pemasangan DJ stent.
 - d. Batu dengan densitas maksimal 1.000 HU.
 - e. Jarak kulit dengan batu maksimal 10 cm.
 - f. Kewenangan pelaksanaan tindakan ESWL ada pada Dokter Spesialis Urologi
 - g. Pada Layanan ESWL yang menggunakan radiasi pengion (membutuhkan izin BAPETEN), tindakan ESWL dilakukan oleh DPJP yang namanya tercantum dalam Lampiran Data Teknis Petugas yang Menangani Sumber Radiasi Pengion Izin BAPETEN.
7. Kontraindikasi tindakan ESWL
 - a. Gangguan skeletal berat dan obesitas berat
 - b. Infeksi saluran kemih yang belum terkontrol
 - c. Kehamilan
 - d. Terdapat aneurisma pada daerah sekitar batu
 - e. Obstruksi distal secara anatomi yang dapat menghambat turunnya batu
 - f. Kelainan perdarahan, yang tidak dapat dikompensasikan dalam waktu setidaknya 24 (dua puluh empat) jam sebelum dan 48 (empat puluh delapan) jam setelah tata laksana.
8. Pencitraan (*Imaging*)

Pemeriksaan CT Scan abdomen sangat direkomendasikan sebagai pemeriksaan penunjang yang optimal untuk meningkatkan angka keberhasilan tindakan ESWL. Salah satu faktor utama yang berperan penting dalam keberhasilan tindakan ESWL dan mencegah kejadian ESWL berulang adalah ketepatan dalam menentukan jenis, ukuran, dimensi, densitas dan posisi batu saluran kemih, yang bisa didapatkan dengan menggunakan CT scan abdomen.

 - a. Standar Diagnostik ESWL
 - CT Scan Abdomen
 - 1) Menentukan ukuran dan densitas batu
 - 2) Memberikan gambaran dimensi batu yang adekuat
 - 3) Mendeteksi batu radiolusen dengan nilai sensitivitas dan spesifitas tinggi
 - 4) Mengukur jarak antara kulit dan batu, serta anatomi sekitarnya
 - b. Pencitraan Lainnya
 - USG
Berguna untuk mengidentifikasi batu pada kaliks, pelvis, sambungan pieloureter dan vesikoureter, dan buli-buli dengan nilai spesifitas yang baik.
 - Foto polos abdomen atau sinar X kidney-ureter-bladder (KUB)
Berguna untuk membedakan batu radioopak dan radiolusen serta kepentingan follow-up pasca tindakan.
 - IVU
Merupakan pemeriksaan alternatif apabila CT abdomen tidak memungkinkan
 - MRI
Dipertimbangkan sebagai modalitas lini kedua untuk populasi yang rentan terhadap efek teratogenik dan karsinogenesis, misalnya wanita hamil dan anak.

9. Penjaminan maksimal Tindakan ESWL Berulang:

- a. Jumlah ideal maksimal ESWL kurun waktu tertentu, yaitu 4 (empat) kali pada satu sisi (kanan atau kiri) dalam kurun waktu satu tahun, berlaku akumulasi untuk seluruh batu saluran kemih (Rekomendasi PP IAU melalui Surat Nomor: 0053/STa.001/PP.IAU/I/2024).
- b. Penjaminan sesi tambahan ESWL dilakukan dengan memastikan terdapat perbaikan dalam hal pengurangan ukuran batu yang tersisa setelah tindakan awal/sebelumnya. Tindakan ESWL yang telah memenuhi kriteria indikasi dan telah mengoptimalkan faktor pendukung, akan mendapatkan angka keberhasilan bebas batu (stone free rate) yang tinggi dalam satu kali tindakan ESWL
- c. Sisa batu setelah tindakan ESWL dibuktikan melalui pemeriksaan pencitraan, yang optimal dilakukan dalam waktu 4 minggu setelah tindakan pertama (rekomendasi dari panduan *European Association of Urology*).
- d. Hasil pencitraan yang menunjukkan masih terdapat sisa batu ginjal dengan ukuran > 4 mm menunjukkan kemungkinan untuk dilakukan sesi ESWL tambahan, dengan pertimbangan bahwa batu ginjal ukuran maksimal 4 mm dapat keluar secara spontan (SFR = 80%).
- e. Jika tindakan ESWL telah mencapai 4 kali dalam setahun namun masih dibutuhkan tata laksana pengangkatan batu, maka untuk keberlangsungan tata laksana kasus batu saluran kemih terdapat pilihan Tindakan pengangkatan batu lainnya, seperti PCNL (*Percutaneous Nephrolithotomy*), URS (*ureterorenoskopi*), dan atau operasi pengangkatan terbuka/laparoskopik sesuai dengan panduan dalam PNPK.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala

\$\$

Roni Kurnia Hadi Permana

Lampiran Daftar Tujuan Surat

1. Direktur RSUD dr Saiful Anwar
2. Direktur RSU Karsa Husada Batu
3. Direktur RS TK II dr Soepraoen
4. Direktur RS Persada Hospital
5. Direktur RS Lavalette
6. Direktur RS Wava Husada
7. Direktur RS Prima Husada